

НАУЧНАЯ СЕССИЯ ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тезисы докладов

Редактор Н.А.Щепина

Корректоры М.Н.Афанасьева, И.В.Малюткина

Лицензия ЛП №020930 от 26.10.94

Сдано в набор 22.01.99. Подписано в печать 02.04.99.

Формат 60x84¹/₈. Бумага для ксерокопирования.

Усл. печ. л. 27. Уч.-изд. л. 37. Заказ №20. Тираж 100 экз.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Кафедра госпитальной терапии №2

Цель работы – изучение особенностей пневмоний (ПН), возникающих на фоне сахарного диабета (СД). Выделено две группы больных: 1-я – 16 пациентов с сочетанием ПН и СД, 2-я – 32 больных ПН без сопутствующего СД. По полу и возрасту группы сопоставимы. Анализировались клинические, рентгенологические и лабораторные показатели ПН и СД. У 88% больных первой группы выявлялась декомпенсация СД. Более чем в половине случаев (56%) имелись различные осложнения СД. Кетоацидоз развился у 9 больных: в 2/3 случаев ПН возникла на фоне кетоацидоза, и лишь в 1/3 – ПН предшествовала кетоацидозу. Нами не выявлено различий в клинической картине ПН между больными 1-й и 2-й групп: преобладает правосторонняя локализация процесса (в 62% в 1-й и в 56% во 2-й группе) с преимущественным поражением нижней доли. ПН расценена как очаговая в 31%, как долевая – в 69% в обеих группах. Плеврит в 1-й группе пациентов встречался в 2 раза чаще (44%), чем во 2-й. Разрешение пневмонии, по рентгенологическим данным происходило на неделю раньше у больных без СД (15 дней), чем на фоне СД (21 день), различие достоверно ($T=2,5$). Лейкоцитоз зарегистрирован у 37% больных 1-й группы и только в 12% – во 2-й группе. Нейтрофильный сдвиг влево мы обнаружили у 81% больных 1-й и лишь у 56% 2-й группы ($T=2,6$). Анэозинофилия определялась в 31% и 9% случаев в 1-й и 2-й группах соответственно. Длительное повышение СОЭ имело место у 75% в 1-й и у 56% пациентов во 2-й группе. Средние сроки пребывания в стационаре с ПН у больных с СД составили 30 дней, у лиц без СД – 15 дней.

Таким образом, пневмония на фоне сахарного диабета отличается торпидностью течения, более выраженным сдвигом лейкоформулы влево, частой анэозинофилией по сравнению с таковой у пациентов без диабета.

С
с БА
до 6
(70,8
по т
охва
и и
Даль
прох
О
и ва
зульт
паци
не зар
тализ
питал
дней
Та
ся важ
данно
тивны

ДИ
С
(
СІ

Исс
сыворо
астмой,
заболев
(полли
спелеот
действи
Березни
280 час
ситуаци

Выяв
следуем
ммоль/л
холестер
процессе
повышен